

TEMA 3.31 • OBSTETRICIA

Embarazo Gemelar — Clasificación y Diagnóstico

PERFIL EUNACOM 1.03.31
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Embarazo Gemelar — Clasificación y Diagnóstico

Incidencia

~1% de los embarazos. Principal factor de riesgo: **fertilización asistida** (FIV, inducción de ovulación).

Clasificación

Por cigosidad

TABLA 3.31.1: TIPO VS CARACTERÍSTICAS			
TIPO	CARACTERÍSTICAS	CORIONICIDAD	AMNIONICIDAD
Dicigóticos (70%)	2 óvulos + 2 espermios distintos; distintos genéticamente	Siempre bicoriales	Siempre biamnióticos
Monocigóticos (30%)	1 cigoto que se divide; idénticos genéticamente	Bicorial o monocorial	Biamniótico o monoamniótico

Por corionicidad (lo más importante para el pronóstico)

TABLA 3.31.2: TIPO VS PORCENTAJE		
TIPO	PORCENTAJE	RIESGO
Bicorial-biamniótico	~80%	Menor
Monocorial-biamniótico	~19%	Mayor
Monocorial-monoamniótico	< 1%	Máximo
Siameses (pagos)	< 1%	Máximo (siempre MC-MA)

Diagnóstico Ecográfico de Corionicidad

TABLA 3.31.3: SIGNO ECOGRÁFICO VS CORIONICIDAD	
SIGNO ECOGRÁFICO	CORIONICIDAD
Signo lambda (λ) — tejido placentario entre las membranas	Bicorial
Signo T — membranas en ángulo recto	Monocorial

PERLA CLÍNICA EUNACOM
Diagnóstico más preciso en el **1er trimestre** (antes de las 14 semanas). A mayor EG, más difícil determinar la corionicidad.

Escala de riesgo

Bicorial < Monocorial-biamniótico < **Monocorial-monoamniótico** = máximo riesgo

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"En relación a Embarazo Gemelar — Clasificación y Diagnóstico: Embarazo Gemelar — Clasificación y Diagnóstico ## Incidencia ~1% de los embara... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Embarazo Gemelar — Clasificación y Diagnóstico. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Incidencia
- Clasificación
- Por cigosidad
- Por corionicidad (lo más importante para el pronóstico)
- Diagnóstico Ecográfico de Corionicidad
- Escala de riesgo
- fertilización asistida

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (EMBARAZO GEMELAR — CLASIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO)**PREGUNTA 1**

En relación a Embarazo Gemelar — Clasificación y Diagnóstico: Embarazo Gemelar — Clasificación y Diagnóstico ## Incidencia ~1% de los embarazos. ¿cuál es la conducta correcta?

- A)** El diagnóstico de Embarazo Gemelar — Clasificación y Diagnóstico se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Embarazo Gemelar — Clasificación y Diagnóstico debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Embarazo Gemelar — Clasificación y Diagnóstico requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Embarazo Gemelar — Clasificación y Diagnóstico es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Embarazo Gemelar — Clasificación y Diagnóstico no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Embarazo Gemelar — Clasificación y Diagnóstico?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Embarazo Gemelar — Clasificación y Diagnóstico. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: EMBARAZO GEMELAR — CLASIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO

~1% de los embarazos. Principal factor de riesgo: fertilización asistida (FIV, inducción de ovulación). ::::tip Diagnóstico más preciso en el 1er trimestre (antes de las 14 semanas). A mayor EG, más difícil determinar la corionicidad. :::